

**PLANO DE CONTINGÊNCIA
PARA ENFRENTAMENTO DA DENGUE NO PERÍODO SAZONAL
2024/2025**



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE



MISSÃO

"Promover saúde e bem-estar para as pessoas."



VISÃO

"Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil."

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



SECRETÁRIO DE SAÚDE

Rodrigo Andrioli

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Marlene Bonow de Oliveira

DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE

Douglas Calheiros Machado

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Maria Guilhermina Murtinho de Borba

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Ana Cláudia Franz Schuch

GERÊNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Ana Aparecida Pereira – Distrito Norte

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Centro

Jaqueline Fornari – Distrito Sul

GERÊNCIA DE ENFERMAGEM E GESTÃO ASSISTENCIAL

Vanessa Cardoso Pacheco

GERÊNCIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ARTICULAÇÃO DA REDE EM SAÚDE

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Felipe Massignan

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ARTICULAÇÃO HOSPITALAR

Thiago Ramos

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Anderson da Silva

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Allisson Domingos

Elaborado em Outubro 2024



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. SITUAÇÃO ENTOMOLÓGICA E EPIDEMIOLÓGICA.....	6
Tabela 01. Focos de <i>Aedes aegypti</i> , 2010-2024* no Município de Joinville.....	6
Tabela 02. Levantamento Rápido de Índices para <i>Aedes aegypti</i> (LIRAA) no Município de Joinville.....	7
Tabela 03. Casos Suspeitos de Dengue Notificados em 2015-2024* em Residentes no Município de Joinville.....	8
Gráfico 1. Distribuição dos Casos de Dengue em 2020-2024* por Semana Epidemiológica em Residentes no Município de Joinville.....	9
Gráfico 2. Distribuição dos Casos de Dengue em 2020-2024* com Sinais de Alarme e Dengue Grave em Residentes no Município de Joinville.....	10
Gráfico 3. Distribuição dos Casos de Dengue em 2020-2024* que necessitaram de Internação e Casos de Dengue que tiveram como Desfecho Óbito em Residentes no Município de Joinville....	11
3. JUSTIFICATIVA.....	11
4. ESTRATÉGIAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA.....	12
Quadro 01. Níveis de Alerta, Indicadores de Acionamento e Ações do Plano de Contingência de Dengue 2024/2025.....	13
4.1. Ações Contínuas.....	18
4.1.1. Comunicação, Mobilização e Publicidade.....	18
4.1.2. Gestão.....	19
5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.....	19
REFERÊNCIAS.....	20
Anexo 1. Equipe que compõe a Sala de Situação.....	22
Anexo 2. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue Pediátrico na APS.....	23
Anexo 3. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue Adulto na APS.....	24
Anexo 4. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue Pediátrico nas UUE.....	25
Anexo 5. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue Adulto nas UUE.....	26
Anexo 6. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue nas Unidades de Apoio de Hidratação (UAH).....	27
Anexo 7. Fluxograma de Monitoramento dos Casos de Dengue – Monitora Dengue.....	28
Anexo 8. Fluxograma Coleta de Hemograma para Dengue B nas UAHs.....	29
Anexo 9. Fluxograma Coleta de Hemograma para Dengue B nas UAHs no período de 18/12/2024 à 02/01/2025.....	30
Anexo 10. Fluxograma Coleta de Hemograma para o Monitora Dengue - de Segunda à Sexta-Feira.....	31
Anexo 11. Fluxograma Coleta de Hemograma para o Monitora Dengue - nos Sábados, Domingos e Feriados.....	32
Anexo 12. Fluxograma Coleta de Hemograma no Monitora Dengue para < de 7 anos - de Segunda à Sexta-Feira.....	33



1. INTRODUÇÃO

As arboviroses transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti* têm se constituído em um dos principais problemas de saúde pública no mundo, sendo a dengue a arbovirose urbana de maior relevância nas Américas¹.

No Brasil, a dengue se caracteriza por um cenário de transmissão endêmico/epidêmica em grande parte do país, determinada principalmente pela circulação simultânea de vários sorotipos virais (DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4) e a presença disseminada do *Aedes aegypti*. Esse cenário de intensa transmissão tem contribuído para a mudança no perfil da doença, com a ocorrência cada vez maior de suas formas graves e óbitos².

A doença pode apresentar um amplo espectro clínico, variando de casos assintomáticos a graves, sendo possível contrair a doença mais de uma vez, pois a infecção por um sorotipo não gera imunidade para os demais. A maioria dos usuários apresenta evolução clínica leve e se recupera sem maiores complicações, no entanto, parte pode evoluir para formas graves, inclusive levar à óbitos².

A dengue é uma doença de notificação compulsória e todo caso suspeito ou confirmado deve ser notificado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica³ (visualizar o Procedimento Operacional Padrão - POP n° 25 “Como realizar o preenchimento da Notificação Compulsória do agravo Dengue no Sistema Integrado de Gestão (SIG-SaudeTech) no Município de Joinville”, disponível no processo do Sistema Eletrônico de Informação - SEI N° [24.0.226345-2](#)). Esses dados de notificações devem ser utilizados para adoção de medidas de bloqueio adequadas e capazes de reduzir a circulação viral visando a redução do número de casos⁴.



2. SITUAÇÃO ENTOMOLÓGICA E EPIDEMIOLÓGICA

Nos últimos 13 anos, o Município de Joinville tem apresentado elevação progressiva de focos do mosquito *Aedes aegypti*, sendo que, em 2015, com o aumento significativo dos focos, o Município passou a ser considerado infestado com transmissão da doença de forma autóctone, evidenciando a necessidade de preocupação e desenvolvimento de ações específicas das autoridades sanitárias estaduais e municipais quanto à possibilidade de surto e/ou epidemia de dengue.

Em 2019 foi identificado um aumento de 313% dos focos do *Aedes aegypti* em relação ao ano anterior. A partir da vigilância é possível verificar a situação entomológica municipal ao longo dos anos, conforme disponível na tabela (Tabela 01.) abaixo.

Tabela 01. Focos de *Aedes aegypti*, 2010-2024* no Município de Joinville

ANO	Nº DE FOCOS
2010	80
2011	72
2012	112
2013	95
2014	154
2015	231
2016	153
2017	292
2018	807
2019	3.327
2020	6.836
2021	10.223
2022	15.055
2023	15.759
2024*	11.961

Fonte: Vigilantes, 2024.

*dados até outubro/2024.

O Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti* (LIRAa) em Santa Catarina, é realizado conforme orientação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa

Catarina - DIVE - duas vezes ao ano. O LIRAa objetiva a obtenção do Índice de Infestação Predial (IIP) e Índice de Breteau (IB). Estes índices permitem a classificação de risco de epidemia em: baixo, médio e alto. Em Joinville, os últimos LIRAas obtiveram os seguintes índices (Tabela 02.):

Tabela 02. Levantamento Rápido de Índices para *Aedes aegypti* (LIRAa) no Município de Joinville

MÊS/ANO	IIP	IB	RISCO
Novembro / 2020	2,4	2,7	Médio
Março / 2021	5,3	6,2	Alto
Novembro / 2021	2,5	2,7	Médio
Março / 2022	5,9	8,2	Risco Alto
Novembro / 2022	2	2,9	Médio
Março / 2023	7,1	9,7	Risco Alto
Janeiro / 2024	8,3	10,7	Risco Alto
Outubro / 2024	1,4	1,7	Médio

Fonte: Vigilantes, 2024.

*dados até outubro/2024

A partir de 2020, em Joinville a transmissão de dengue para humanos passou a ser considerada como epidemia (quando a incidência do agravo chega a 300 casos/100 mil habitantes) com incidência de 1.460,7 casos/100 mil habitantes e com mais 99% dos casos autóctones.

Em 2021, a incidência foi de 2.716,4 casos/100 mil habitantes, com casos registrados em residentes de todos os bairros. Houve a identificação de circulação viral de dois sorotipos, DENV1 e DENV2 nos dois anos, 2021 e 2022.

Já no ano de 2022, a incidência mais que dobrou em relação a 2020, com 3.456,8 casos/100 mil habitantes com presença de casos confirmados em todos os bairros do município e mantendo a circulação viral dos sorotipos DENV1 e DENV2.

Em 2023 a incidência foi de 7.056 casos/100 mil habitantes, permanecendo apenas os sorotipos DENV1 e DENV2.

Até a Semana Epidemiológica (SE) 37 de 2024 a incidência de casos chegou a 13.326,8 casos/100 mil habitantes, permanecendo a circulação apenas dos sorotipos

DENV1 e DENV2. Se compararmos o ano 2024 com 2020, houve um aumento de 940,8% dos casos confirmados.

A tabela ([Tabela 03.](#)) abaixo apresenta a série histórica desde 2015 de casos suspeitos e confirmados de dengue notificados no Município de Joinville.

Tabela 03. Casos Suspeitos de Dengue Notificados em 2015-2024* em Residentes no Município de Joinville

ANO	SUSPEITOS	CONFIRMADOS	INCIDÊNCIA (100 MIL HAB.)
2015	375	47	8,8
		12,50%	
2016	241	28	5,3
		11,60%	
2017	108	0	0,0
		0,00%	
2018	54	5	0,9
		9,26%	
2019	125	19	3,2
		15,20%	
2020	13.075	8.730	1.460,7
		66,8%	
2021	25.454	16.426	2.716,4
		64,5%	
2022	32.398	21.305	3.456,8
		65,8%	
2023	65.681	43.488	7.056,0
		66,2%	
2024*	105.125	82.136	13.326,8
		78,1%	

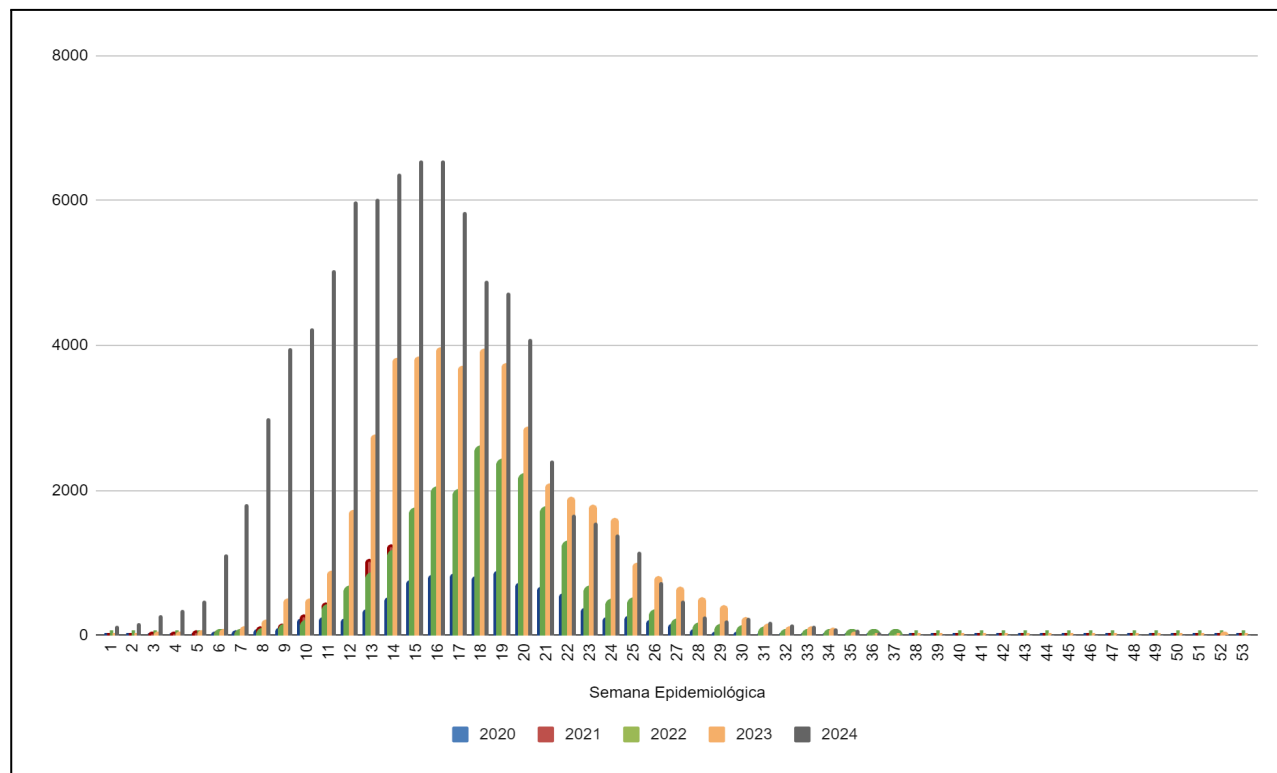
Fonte: SINAN, atualizado em 17/09/2024.

*2024 dados preliminares

O [Gráfico 1.](#) demonstra a evolução dos casos de dengue ao longo das SE. No ano de 2020 o maior número de casos registrados foi entre as SE 15 a 21, em 2021 o pico foi entre as semanas 13 e 21, já no ano de 2022 o maior número de casos foi entre as semanas 15 a 22. Em 2023 houve uma antecipação na curva epidemiológica, apresentando maior número de casos entre as semanas 12 a 20, e o pico se deu na semana 16.

Em 2024, a curva epidemiológica apontou aumento de casos na SE 08 e atingiu o pico na semana 15 e 16, identificando um período sazonal mais prolongado quando comparado com os anos anteriores.

Gráfico 1. Distribuição dos Casos de Dengue em 2020-2024* por Semana Epidemiológica



em Residentes no Município de Joinville

Fonte: SINAN, atualizado em 17/09/2024.

*2024 dados preliminares

Em relação às formas graves da doença, em 2020 foram identificados 93 casos de dengue com sinais de alarme, o que representou 1,07% dos casos e não foram registrados casos de dengue grave e/ou óbitos. Já em 2021 foram 135 casos de dengue com sinais de alarme, representando 0,82% dos casos de dengue, 8 casos de casos graves, que representaram 0,05% dos casos, com um total de 5 óbitos registrados, como demonstrado no [Gráfico 2](#).

Em 2022 houve um aumento significativo do número de casos, sendo notificados 925 casos de dengue com sinais de alarme, equivalente a 4,34% dos registros, 33 registros de dengue grave, representando 0,15% das notificações, sendo que desses, 19 foram a óbito.

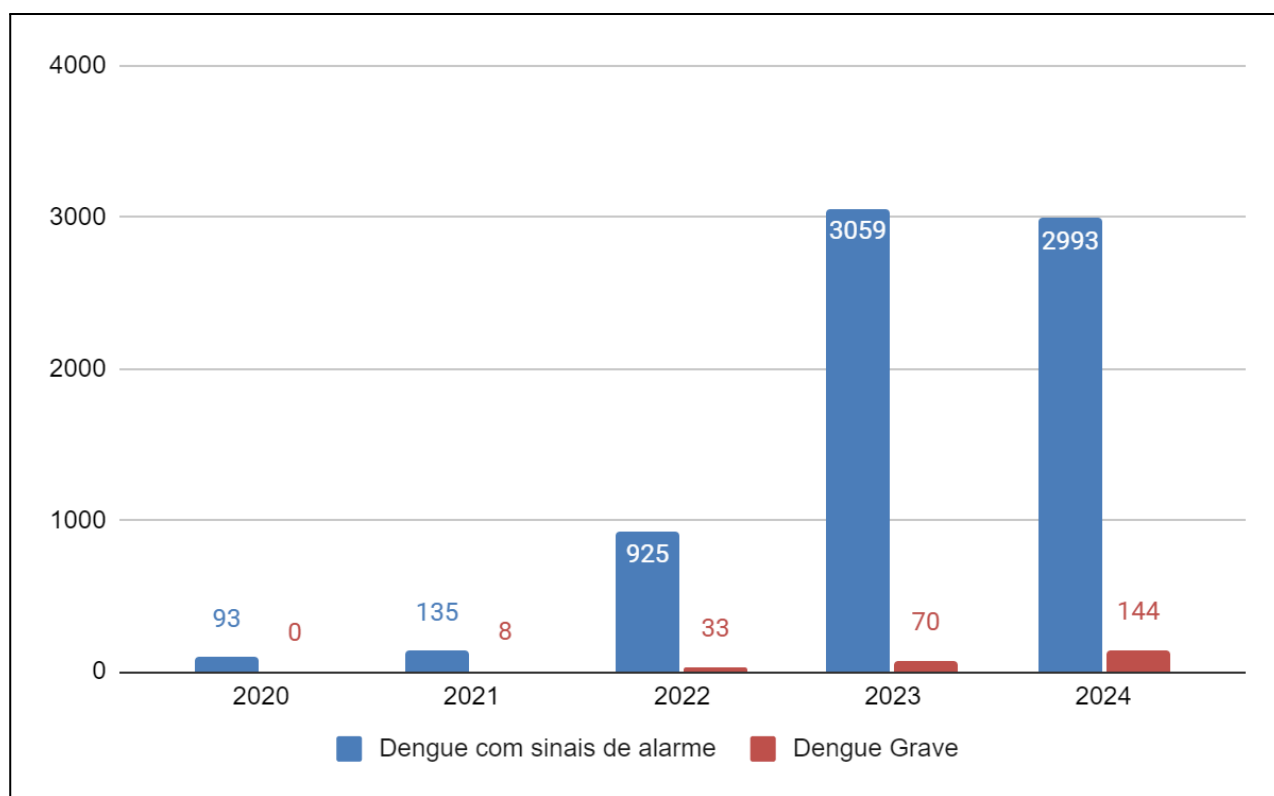
Em 2023 houveram 3059 casos de dengue com sinais de alarme, que representaram 7,3% dos casos, e 70 casos de dengue grave, equivalente a menos de 0,16%, sendo confirmados 39 óbitos por dengue.

Observa-se que até a SE 37 foram registrados 2.993 casos com sinais de alarme, representando 3,6% dos casos, e 144 casos de dengue grave, equivalente a 0,17%. Já em relação aos óbitos, houve um aumento de 112,8% em 2024, quando comparado ao ano de 2023 (Gráfico 2.).

Cabe salientar que, os casos de dengue com sinais de alarme e ou gravidade, representam uma parcela de maior impacto para os serviços, visto que muitos destes casos podem necessitar de internação hospitalar.

O Gráfico 3. demonstra o aumento nos casos de dengue que necessitaram de internação entre 2020 e 2024, bem como o número de óbitos nestes anos. É importante considerar que, em uma nova exposição ao vírus da dengue com sorotipo diferente, a gravidade da doença e a patogenicidade do vírus tendem a ser mais intensos, tornando o prognóstico da doença cada vez mais desfavorável.

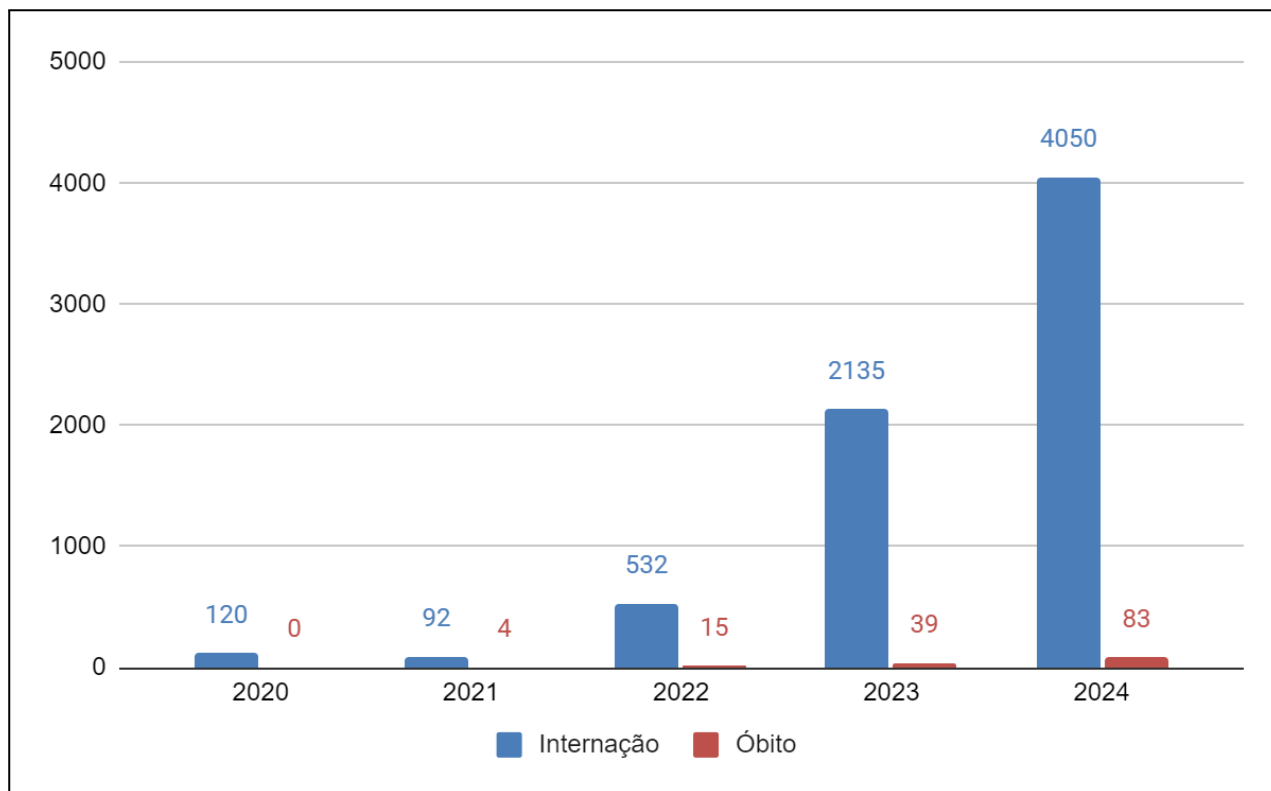
Gráfico 2. Distribuição dos Casos de Dengue em 2020-2024* com Sinais de Alarme e Dengue Grave em Residentes no Município de Joinville



Fonte: SINAN, atualizado em 17/09/2024.

*2024 dados preliminares

Gráfico 3. Distribuição dos Casos de Dengue em 2020-2024* que necessitaram de Internação e Casos de Dengue que tiveram como Desfecho Óbito em Residentes no Município de Joinville



Fonte: SINAN, atualizado em 17/09/2024.

*2024 dados preliminares

3. JUSTIFICATIVA

O Plano de Contingência para o enfrentamento da dengue em Joinville, direciona tanto as questões organizativas assistenciais quanto à ambiental. As estratégias a serem adotadas contemplam os aspectos relacionados à vigilância em saúde, controle vetorial, assistência ao usuário, gestão, transporte, insumos, mobilização e comunicação social ^{4, 5, 6}, baseadas em documentos norteadores do Ministério da Saúde para a sua elaboração.

Este documento tem por objetivo auxiliar na resposta (ações de controle) à epidemia de dengue no Município de Joinville, e ainda no combate desta arbovirose, cujas consequências podem provocar sérios danos às pessoas, ao meio ambiente e à economia dos entes integrantes do Sistema Único de Saúde. Conjuntamente, o mesmo define responsabilidades nos diferentes níveis de atenção e organização necessária para atender as situações de emergência relacionadas ao agravo, visando à integralidade das ações, à prevenção e ao controle dos processos epidêmicos ⁵.

Considerando que, no Município já foi confirmada a transmissão de pelo menos dois sorotipos virais (DENV 1 e DENV 2), e que neste ano houve a confirmação de novos casos de dengue no país pelo sorotipo DENV 3, cuja identificação não ocorria há 15 anos, podendo aumentar o risco de uma epidemia com o retorno do sorotipo 3, considerando a baixa imunidade da população a este sorotipo da dengue.

Portanto, faz-se necessário o alinhamento das ações e engajamento de todos os envolvidos no presente Plano de Contingência, a fim de minimizar o impacto da doença e reduzir possíveis complicações ao indivíduo.

4. ESTRATÉGIAS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

A implementação do Plano estabelece atividades específicas a serem aplicadas em cinco níveis de alerta, conforme Quadro 01, abaixo, com indicadores de acionamento para cada nível⁷.

Quadro 01. Níveis de Alerta, Indicadores de Acionamento e Ações do Plano de Contingência de Dengue 2024/2025

NÍVEL DE ALERTA	INDICADOR DE ACIONAMENTO	AÇÕES
Nível 1 <u>Normalidade</u> <u>(Verde)</u>	→ Notificação de Casos Autóctones Esporádicos	➤ Revisar o plano de contingência; ➤ Acompanhar, monitorar e disponibilizar os dados da situação epidemiológica no município; ➤ Qualificar os dados em saúde gerados pela Vigilância Epidemiológica, realizando parcerias com instituições de ensino; ➤ Receber notificações de casos suspeitos e alimentar o Sistema de Informação de Notificação de Agravos Nacional Online (SINAN online); ➤ Aprimorar o robô de inserção dos dados no SINAN online e buscar o desenvolvimento do robô para encerramento dos casos; ➤ Realizar visitas domiciliares por meio dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) para orientação e eliminação de focos; ➤ Orientar a intensificação do controle vetorial nos locais de permanência dos casos suspeitos e confirmados em seu período de viremia; ➤ Cobrir em 80% dos domicílios nas áreas com focos positivos durante dois ciclos (Delimitação de foco + 1 ciclo de Li+T); ➤ Realizar a distribuição de repelentes para durante as ações multisetoriais realizados pela Vigilância Ambiental; ➤ Realizar inspeção nos cemitérios; ➤ Realizar visitas nos pontos estratégicos; ➤ Executar as ações de controle ao vetor com tratamento perifocal, bem como bloqueio de transmissão com aplicação de inseticida à Ultra Baixo Volume (UBV) com máquina costal motorizada, usando máscaras para aplicação de inseticidas e insumos, quando a situação indicar; ➤ Executar ações de bloqueio de transmissão utilizando equipamento UBV portátil ou pesado, mediante avaliação da Gerência Estadual de Zoonoses (GEZOO/DIVE); ➤ Implementar o método Wolbachia realizando a soltura dos wolbitos;

		➤ Realizar atividades de educação ambiental na comunidade, escolas, empresas e outros locais estratégicos; ➤ Promover ações de fiscalização e incluir a Vigilância Sanitária como suporte às ações de vigilância e controle vetorial que necessitem de medidas legais e que exigem o cumprimento da legislação sanitária; ➤ Orientar e fiscalizar os estabelecimentos vistoriados para Licenciamento Sanitário, visando o controle do <i>Aedes aegypti</i> e demais pragas urbanas; ➤ Realizar dimensionamento de insumos existentes e prospecção de materiais (Soro fisiológico, Soro de Reidratação oral, equipos, material de punção, testes rápidos, medicamentos, entre outros); ➤ Levantar as necessidades de: transporte, tecnologia de informação, gestão de pessoas e demais itens necessários para organização do local e atendimento ao usuário a partir do nível 2; ➤ Realizar capacitação dos profissionais de saúde para o manejo da dengue; ➤ Qualificar o manejo através da hidratação endovenosa oportuna para usuários impossibilitados de hidratação por via oral, por meio da disponibilização de poltronas nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs); ➤ Monitorar os usuários com dengue do tipo B pela Unidade de Saúde Digital; ➤ Prever o aumento do quantitativo de hemogramas por meio da contratação de equipe; ➤ Prever a contratação de ambulâncias para o transporte sanitário; ➤ Prever a contratação de até 60 leitos de hidratação e observação; ➤ Acionar o plano de comunicação 01 (uma) vez por semana: 1. 10 minutos contra a dengue; 2. Divulgação das ações intersetoriais (mutirões) previstas e os resultados das ações realizadas em 2024; 3. Informativos de prevenção incentivando o uso de repelentes, telas de proteção, roupas leves de mangas compridas em crianças menores de 6 meses; 4. Vacina contra a dengue 10 a 14 anos.
--	--	---

Nível 2 <u>Mobilização (Amarelo)</u>	→ Incidência em ascensão por 02 (duas) semanas consecutivas ; OU → Transmissão simultânea de 02 (dois) ou mais sorotipos	➤ Intensificar todas as ações previstas no nível anterior; ➤ Avaliar as áreas com transmissão mantida por no mínimo 02 (duas) semanas consecutivas, para estabelecer a confirmação pelo critério clínico-epidemiológico. Nestas situações, 10% dos casos notificados autóctones devem realizar a coleta para confirmação laboratorial e monitoramento da circulação viral, exceto gestantes, casos com sinais de alarme, graves e óbitos, que devem ocorrer preferencialmente por critério laboratorial; ➤ Intensificar a confirmação dos casos por critério laboratorial, por meio do encaminhamento de amostras para laboratório de referência - Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN/SC); ➤ Monitorar o sorotipo do vírus circulante por meio do encaminhamento de amostras para laboratório de referência; ➤ Realizar a distribuição de repelentes para os casos suspeitos de dengue; ➤ Iniciar o treinamento dos profissionais que irão compor as equipes das Unidades de Apoio a Hidratação (UAH); ➤ Realizar visitas de avaliação da estrutura física, materiais e alinhamento das informações sobre os fluxos assistenciais da Dengue nas Unidades Básicas de Saúde da Família e nas Unidades de Pronto Atendimento/Pronto Atendimento; ➤ Acionar o plano de comunicação 02 (duas) vezes por semana: 1. Reforçar a campanha 10 minutos contra a dengue - reforçando que a população pode retirar o material impresso nas Unidades Básicas de Saúde; 2. Reforçar a divulgação das ações intersetoriais (mutirões) previstas e os resultados das ações realizadas em 2024; 3. Divulgar a ação BRI (borrifação residual intradomiciliar) feitas em locais críticos; 4. Sinais clínicos da dengue, com orientação para procurar assistência o mais próximo da residência (nas Unidades Básicas de Saúde) (como sugestão utilizar um profissional da rede para produzir vídeos curtos sobre o assunto).
---	--	--

Nível 3 <u>Alerta</u> (Laranja)	→ Incidência permanece em ascensão acima de 02 (duas) semanas consecutivas ; OU → Notificação de caso grave suspeito; OU → Notificação de óbito suspeito	➤ Intensificar todas as ações previstas nos níveis anteriores; ➤ Investigar os casos graves e óbitos; ➤ Analisar diariamente as informações epidemiológicas e laboratoriais com encerramento oportuno das notificações para divulgação digital pelo painel da dengue; ➤ Acionar a abertura de até 03 (três) Unidades de Apoio de Hidratação; ➤ Acionar o aumento do quantitativo de hemogramas realizados; ➤ Acionar o transporte de amostras de hemograma para o laboratório; ➤ Acionar o fluxo do transporte sanitário; ➤ Acionar a abertura de 20 (vinte) leitos da Enfermaria Especializada 24h; ➤ Acionar o plano de comunicação 03 (três) vezes por semana: 1. Reforçar a campanha 10 minutos contra a dengue - reforçando que a população pode retirar o material impresso nas Unidades Básicas de Saúde; 2. Reforçar a divulgação e informar o calendário de ações intersetoriais programadas (mutirão); 3. Reforçar a divulgação da ação BRI (borrifação residual intradomiciliar) feitas em locais críticos; 4. Acionar a Defesa Civil e Guarda Municipal para auxílio nas ações intersetoriais; 5. Divulgar as orientações sobre os sinais e sintomas clínicos da dengue, classificação da dengue e tratamento; 6. Divulgar que o primeiro atendimento deverá acontecer mais próximo da residência (nas Unidades Básicas de Saúde); 7. Divulgar a abertura das 03 (três) Unidades de Apoio a Hidratação.
--	---	--

Nível 4 <u>Situação de Emergência (Vermelho)</u>	→ Incidência de casos permanece em ascensão acima de 04 (quatro) semanas consecutivas, com manutenção de transmissão sustentada; OU → Aumento no número de óbitos	➤ Intensificar todas as ações previstas nos níveis anteriores; ➤ Acionar o Gabinete de Crise; ➤ Acionar a abertura de até mais 06 (seis) Unidades de Apoio a Hidratação; ➤ Acionar a abertura de leitos da Enfermaria Especializada 24h de forma escalonada, iniciando com até 20 (vinte) leitos e posteriormente até mais 20 (vinte) leitos conforme a demanda de atendimentos; ➤ Acionar a abertura de até 03 (três) Unidades de Apoio a Hidratação aos sábados - o acionamento ocorrerá conforme a demanda de atendimentos; ➤ Acionar o plano de comunicação 05 (cinco) vezes por semana: 1. Reforçar a campanha 10 minutos contra a dengue - reforçando que a população pode retirar o material impresso nas Unidades Básicas de Saúde; 2. Reforçar a divulgação e informar o calendário de ações intersetoriais programadas (mutirão); 3. Reforçar a divulgação da ação BRI (borrifação residual intradomiciliar) feitas em locais críticos; 4. Acionar a Defesa Civil e Guarda Municipal para auxílio nas ações intersetoriais; 5. Acionar o Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar e Polícia Civil; 6. Reforçar os sinais clínicos da dengue, com orientação para procurar assistência de saúde (como sugestão utilizar um profissional da rede para produzir vídeos curtos sobre o assunto); 7. Reforçar que o primeiro atendimento deverá acontecer mais próximo da residência (nas Unidades Básicas de Saúde); 8. Divulgar a abertura de mais 06 (seis) Unidades de Apoio a Hidratação, totalizando 09 (nove) Unidades de Apoio a Hidratação; 9. Divulgar a abertura da Enfermaria Especializada 24h.
---	---	--

Nível 5 <u>Crise (Roxo)</u>	→ Incidência de casos permanece em ascensão com esgotamento dos recursos assistenciais do Município	> Acionar as demais instâncias federativas para ampliação e suporte da rede assistencial municipal; > Acionar o plano de comunicação 02 (duas) vezes por dia: 1. Reforçar a campanha 10 minutos contra a dengue - reforçando que a população pode retirar o material impresso nas Unidades Básicas de Saúde; 2. Reforçar a divulgação e informar o calendário de ações intersetoriais programadas (mutirão); 3. Reforçar a divulgação da ação BRI (borrifação residual intradomiciliar) feitas em locais críticos; 4. Acionar a Defesa Civil e Guarda Municipal para auxílio nas ações intersetoriais; 5. Acionar o Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar e Polícia Civil; 6. Reforçar os sinais clínicos da dengue, com orientação para procurar assistência de saúde (como sugestão utilizar um profissional da rede para produzir vídeos curtos sobre o assunto); 7. Reforçar que o primeiro atendimento deverá acontecer mais próximo da residência (nas Unidades Básicas de Saúde); 8. Reforçar os pontos de atendimento assistenciais.
---	---	--

4.1. Ações Contínuas

4.1.1. Comunicação, Mobilização e Publicidade

- Divulgar e disponibilizar informações epidemiológicas para profissionais e população (<https://www.joinville.sc.gov.br/dengue/>);
- Fomentar campanhas para controle do *Aedes aegypti*;
- Divulgar para a população a organização dos serviços para atendimento dos usuários;
- Orientar a população sobre a importância da hidratação precoce, divulgação dos sinais de alarme e procura do atendimento nos serviços de saúde.

4.1.2. Gestão

É fundamental que os gestores municipais conheçam o Plano de Contingência de enfrentamento à dengue, a fim de apoiar e subsidiar as ações propostas, uma vez que, a epidemia instalada gera ônus para o Município, tanto na área da saúde como nas demais.

- Definição de grupo de trabalho para elaboração e articulação de plano de contingência e plano de ação assistencial;
- Manter ativa a Sala de Situação (Anexo 1. - “Equipe que compõe a Sala de Situação”) de enfrentamento à dengue;
- Providenciar e garantir estoque estratégico de insumos necessários;
- Estruturar a rede assistencial para atendimento aos doentes;
- Garantir recursos humanos necessários às ações assistenciais;
- Apoiar a vigilância em saúde na emissão de alertas e orientações aos profissionais de saúde sobre as ações de prevenção e manejo clínico dos usuários;
- Manter o Plano de Contingência Municipal atualizado e acompanhar a sua execução;
- Instrumentalizar-se sobre os recursos financeiros existentes e passíveis de serem utilizados no Programa de Vigilância e Controle do *Aedes aegypti*, com base nos documentos legais.

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O monitoramento contínuo e avaliação da tendência da dengue serão de responsabilidade dos técnicos do Serviço de Vigilância Epidemiológica, por meio de avaliação semanal dos indicadores.

As ações emergenciais serão apresentadas e discutidas na Sala de Situação (Anexo 1. - “Equipe que compõe a Sala de Situação”), para sua aprovação (ou não) e aplicação em todas as unidades envolvidas no atendimento.

A sala de situação manterá reuniões semanais, podendo sofrer alterações conforme evolução da doença no Município de Joinville.

A desativação gradual do plano de contingência será orientada de acordo com os seguintes indicadores: redução da incidência por 02 (duas) semanas consecutivas e tendência de retomada ao nível endêmico da doença (abaixo de 50 casos/100 mil habitantes).

REFERÊNCIAS

- 1 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. **Guia de Vigilância em Saúde: volume único/ 3. ed.** Brasília: Ministério da Saúde, 2019 [citado 2021 Jun 09]. Disponível em: <https://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/junho/25/guia-vigilancia-saude-volume-unico-3ed.pdf>;
- 2 SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. **Vigilância epidemiológica de casos suspeitos de dengue no estado de Santa Catarina.** Florianópolis: Secretaria de Estado da Saúde; 2018. [citado 2021 Jun 09]. Disponível em: https://www.dive.sc.gov.br/conteudos/agrivos/notas_tecnicas/Vigilancia-dengue-27-01-17.pdf;
- 3 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.** Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências. Diário Oficial da União. De Outubro de 1975. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6259.htm;
- 4 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue.** Brasília: Ministério da Saúde; 2009. [citado 2021 Jun 09]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_prevencao_controle_dengue.pdf;
- 5 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. **Plano de Contingência Nacional para Epidemias de Dengue.** Brasília: Ministério da Saúde, 2015. [citado 2021 Nov 30]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/plano_contingencia_nacional_epidemias_dengue.pdf;
- 6 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. **Diretrizes para a organização dos serviços de atenção à saúde em situação de aumento de casos ou de epidemia de dengue. 1ª ed.** Brasília: Ministério da Saúde, 2013. [citado 2021 Nov 30]. Disponível em: <http://www.dive.sc.gov.br/index.php/dengue>;
- 7 SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. **Plano de Contingência Para o Enfrentamento da Dengue, Febre de Chikungunya e Zika Vírus no Estado de Santa Catarina.** Florianópolis: Secretaria de Estado da Saúde; 2021. [citado 2021 Nov 30]. Disponível em: <http://www.dive.sc.gov.br/index.php/dengue>;



8 SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. **Diretrizes Para a Organização dos Serviços De Atenção À Saúde Em Situação de Aumento de Casos ou de Epidemia de Dengue no Estado de Santa Catarina (2022)**. Florianópolis: Secretaria de Estado da Saúde; 2022. Disponível em:

<https://www.dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agrivos/Dengue/Publicacoes/CASOS/Diretrizes-Dengue-SC-09-06-2022.pdf>;

9 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretoria Técnica de Gestão. **Dengue: diagnóstico e manejo clínico – adulto e criança – 5ª edição**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Disponível em:

<https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agrivos/Dengue/Publicacoes/CASOS/5-%20Dengue.%20diagn%C3%B3stico%20e%20manejo%20cl%C3%ADnico.%20adulto%20e%20crian%C3%A7a%202016.pdf>;

10 SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. **Fluxograma de Classificação de Risco e Manejo Clínico do Paciente com Dengue**. Florianópolis: Secretaria de Estado da Saúde; 2023. Disponível em:

<https://dive.sc.gov.br/phocadownload/doencas-agrivos/Dengue/Publicacoes/Fluxograma-Dengue-03-02-2023.pdf>.

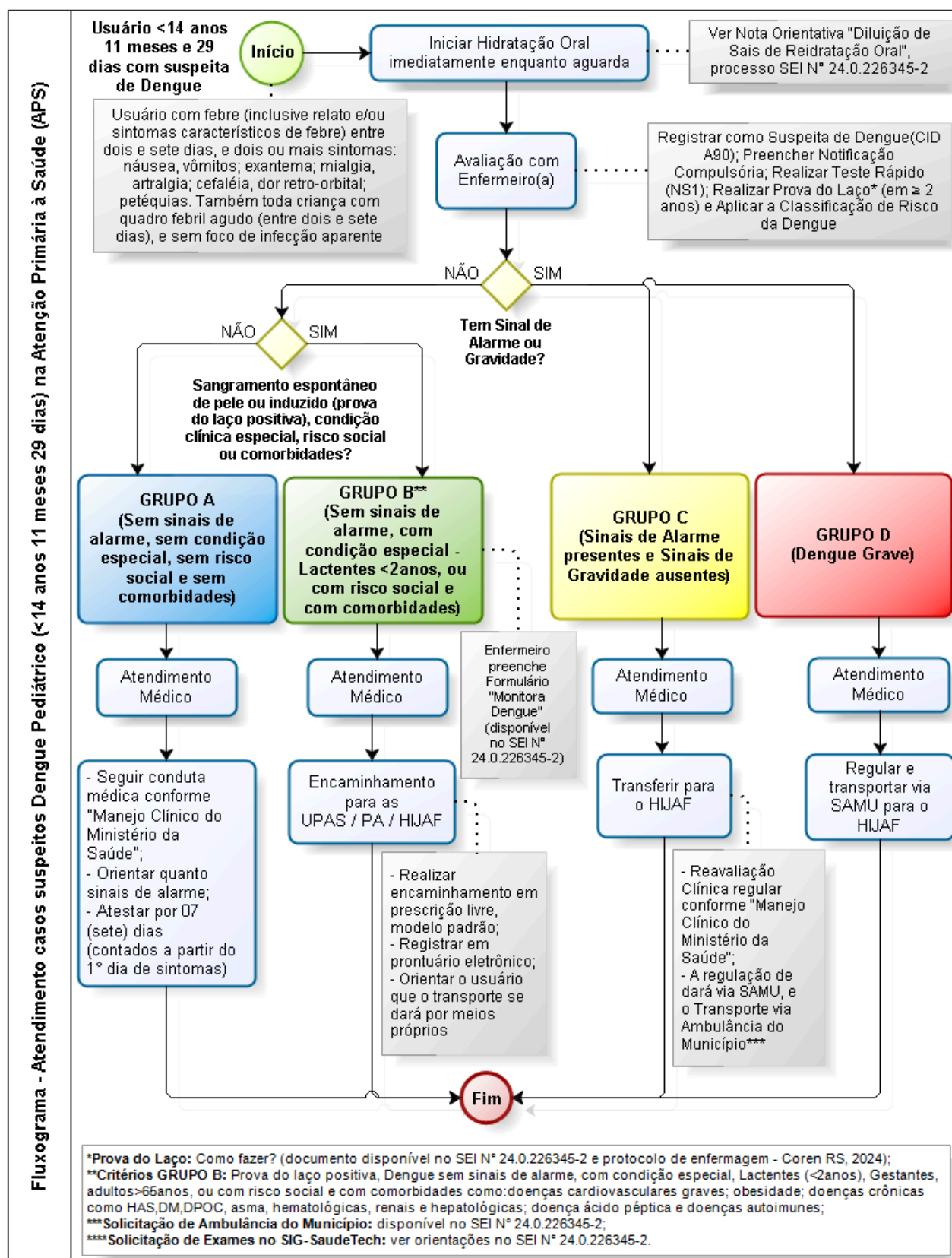


Anexo 1. Equipe que compõe a Sala de Situação

ÁREA	RESPONSÁVEL
Diretoria Executiva da SES	→ Diretoria de Políticas em Saúde → Diretoria de Assistência em Saúde
Vigilância em Saúde	→ Gerente de Vigilância em Saúde → Coordenação de Vigilância Epidemiológica → Técnico da Vigilância Epidemiológica de referência do agravo
Vigilância Ambiental	→ Gerente de Vigilância Ambiental → Coordenação de Vigilância Ambiental
Vigilância Sanitária	→ Gerente de Vigilância Sanitária
Atenção Primária à Saúde	→ Gerentes de Distrito Sanitário
Urgência e Emergência	→ Gerente de Urgência e Emergência
Gestão Estratégica e Planejamento	→ Gerente de Gestão Estratégica e Articulação da Rede
Núcleo de Gestão Assistencial	→ Gerente de Enfermagem e Gestão Assistencial
Administrativa	→ Gerente Administrativo → Coordenação de Transporte → Coordenação de Almoxarifado → Coordenação de Patrimônio
Tecnologia da Informação	→ Gerente de Tecnologia da Informação
Laboratório e Farmácia	→ Gerente de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal

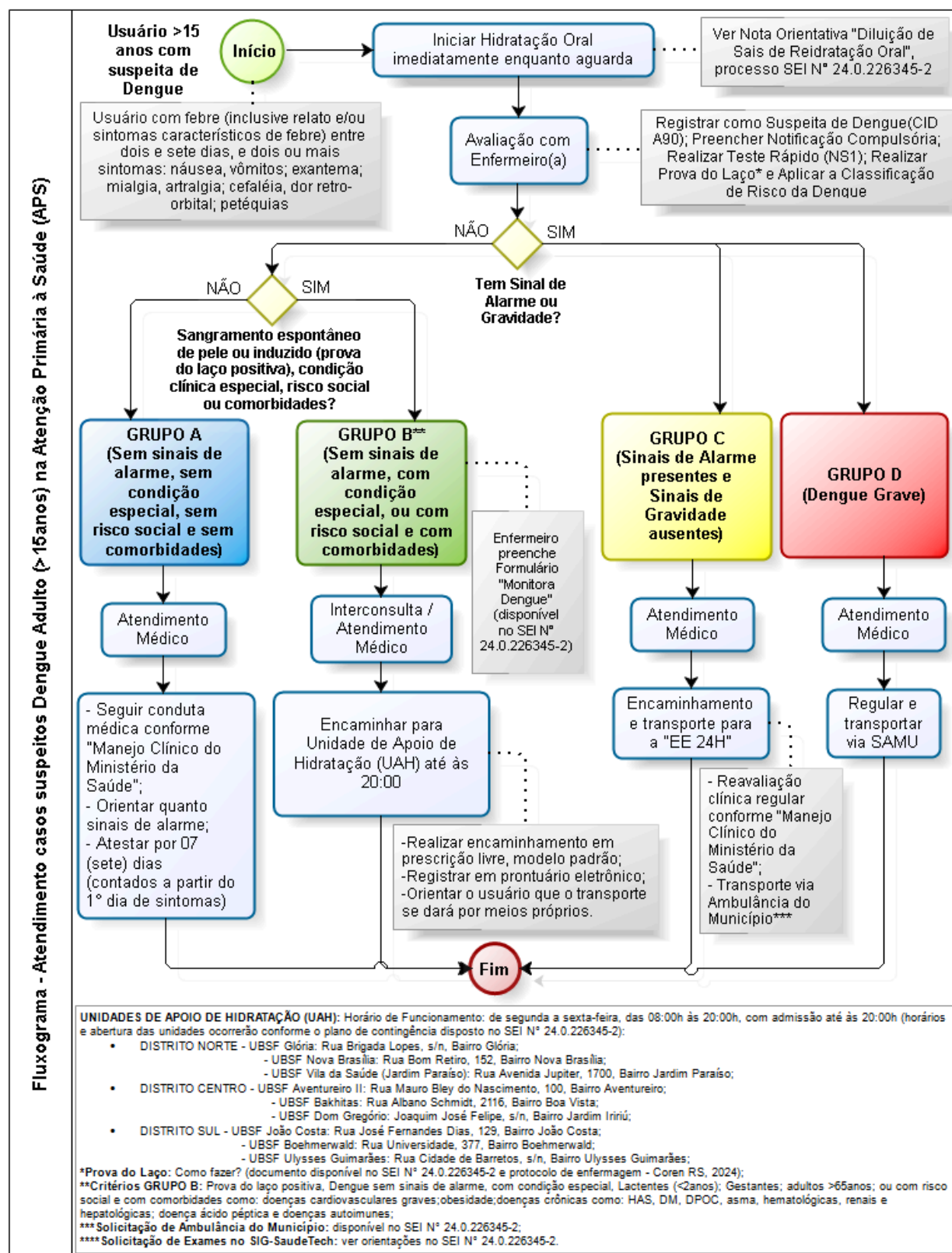
Fonte: SMS, 2024.

Anexo 2. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue Pediátrico na APS



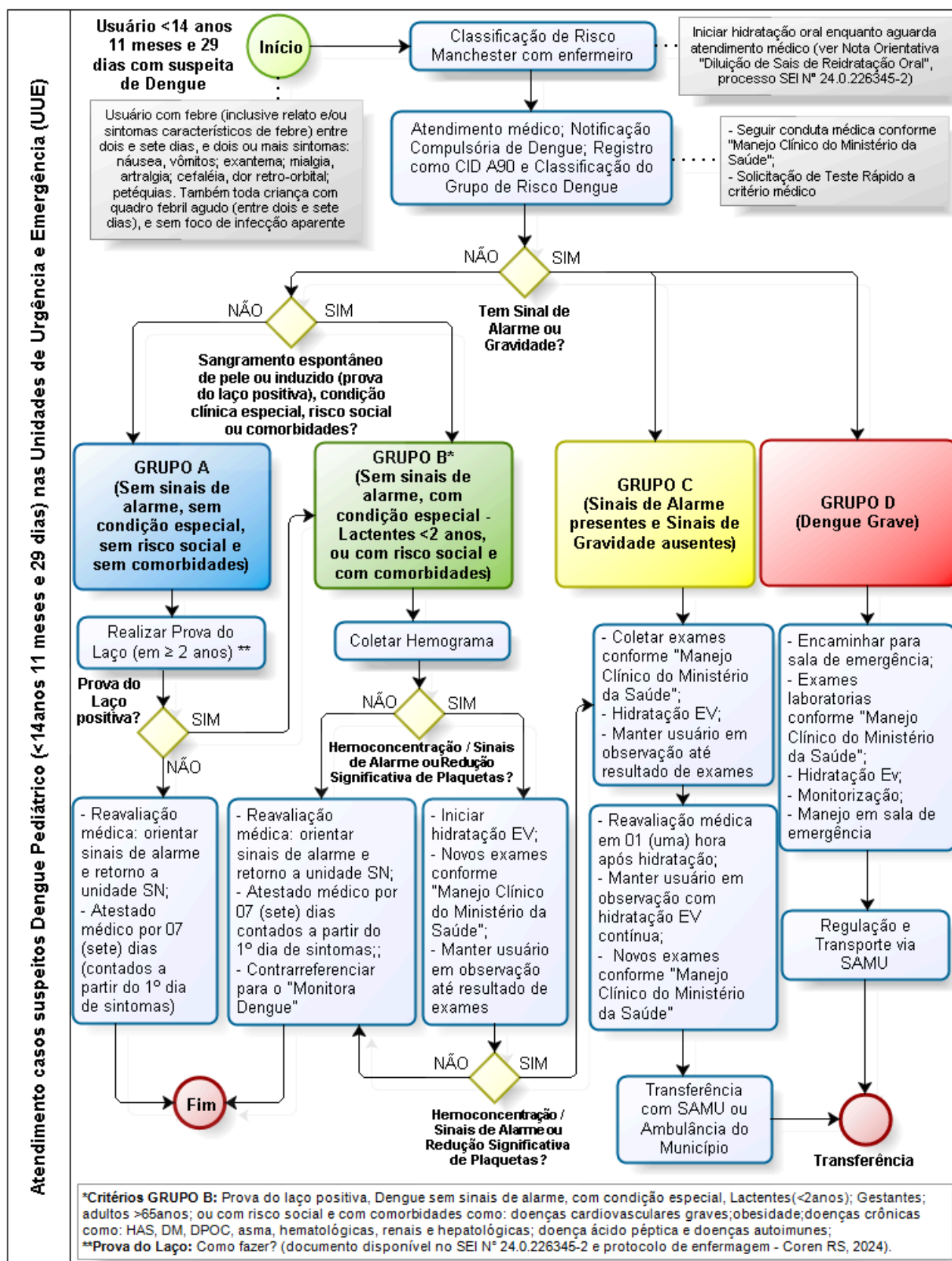
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 3. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue Adulto na APS



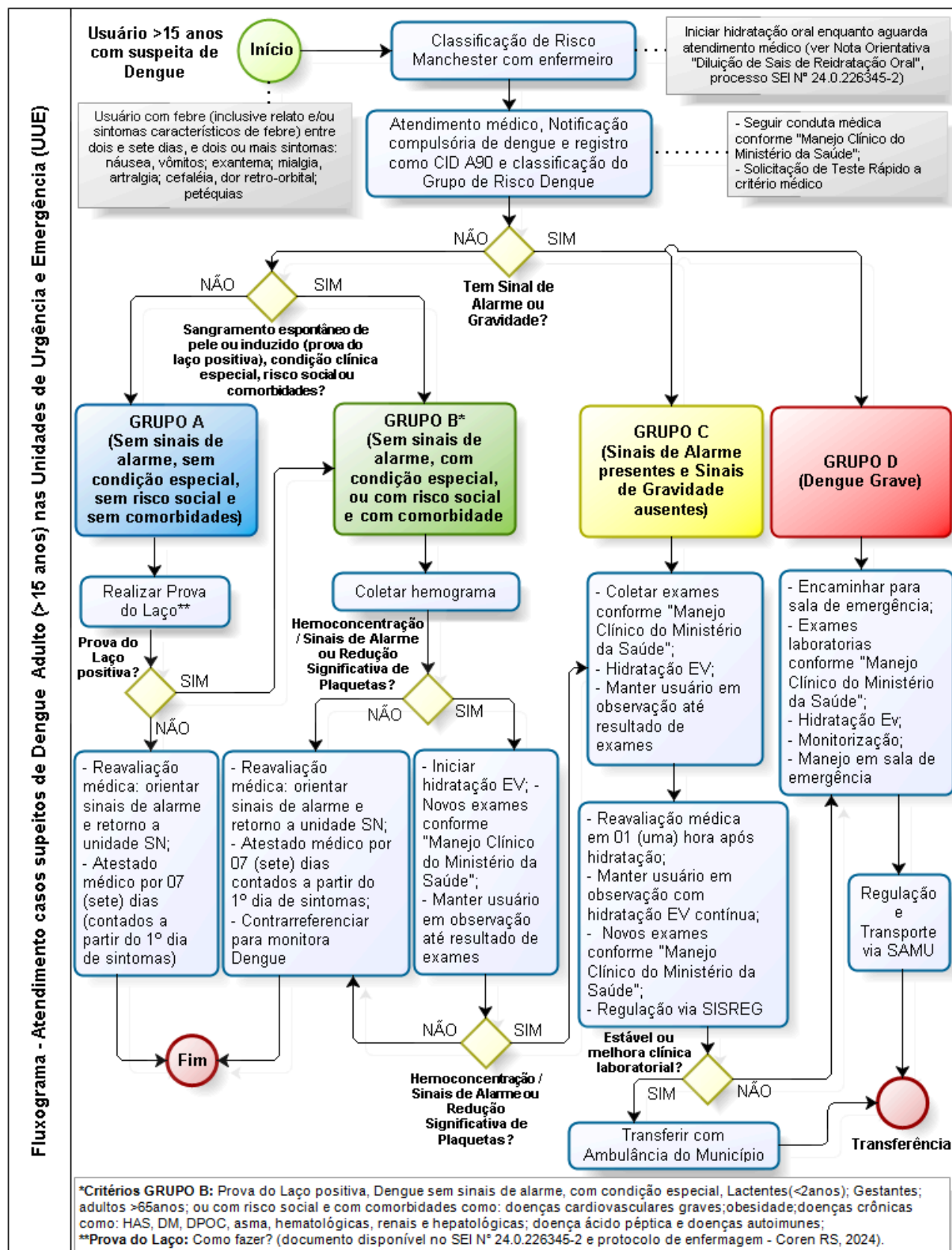
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 4. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue Pediátrico nas UUE



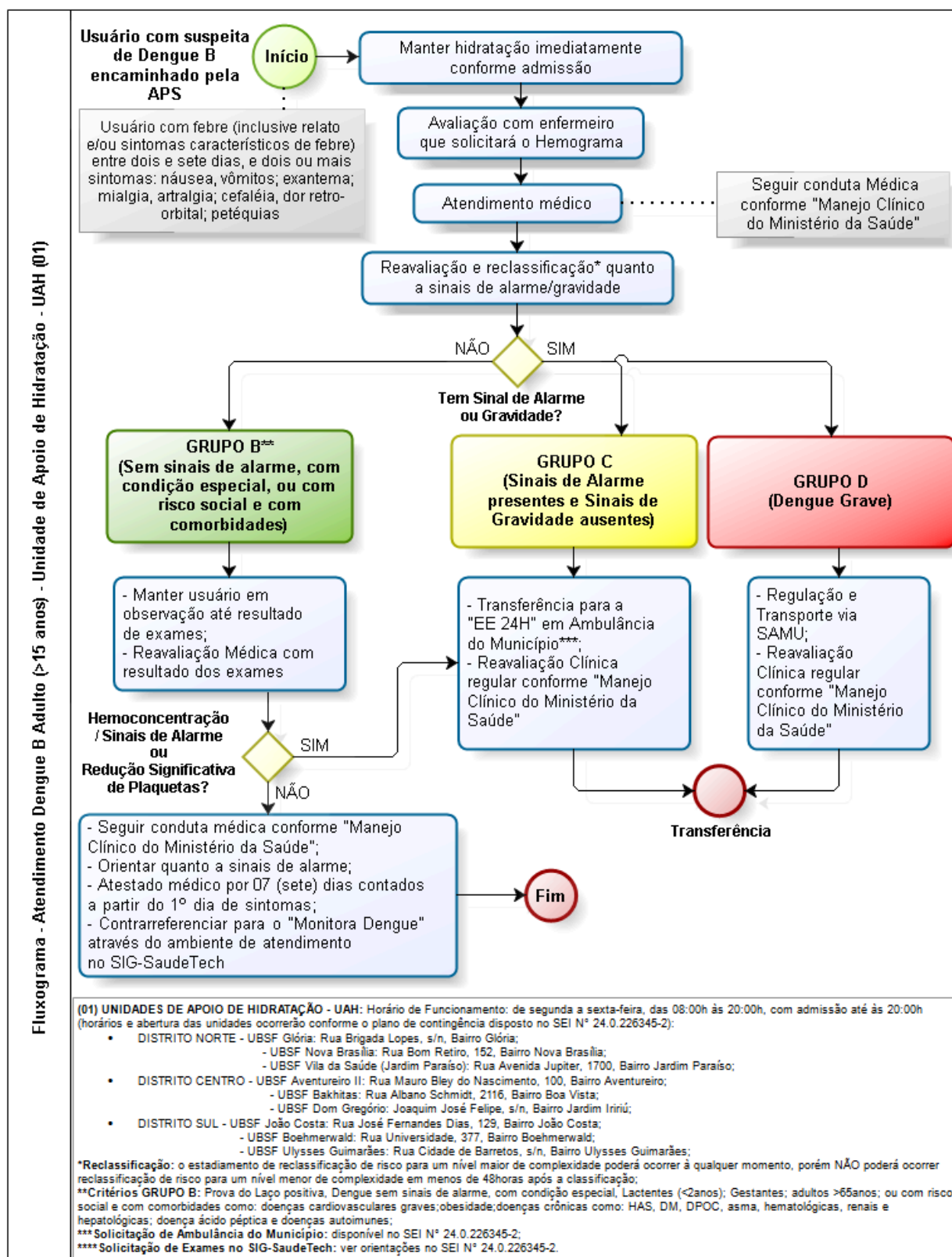
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 5. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue Adulto nas UUE



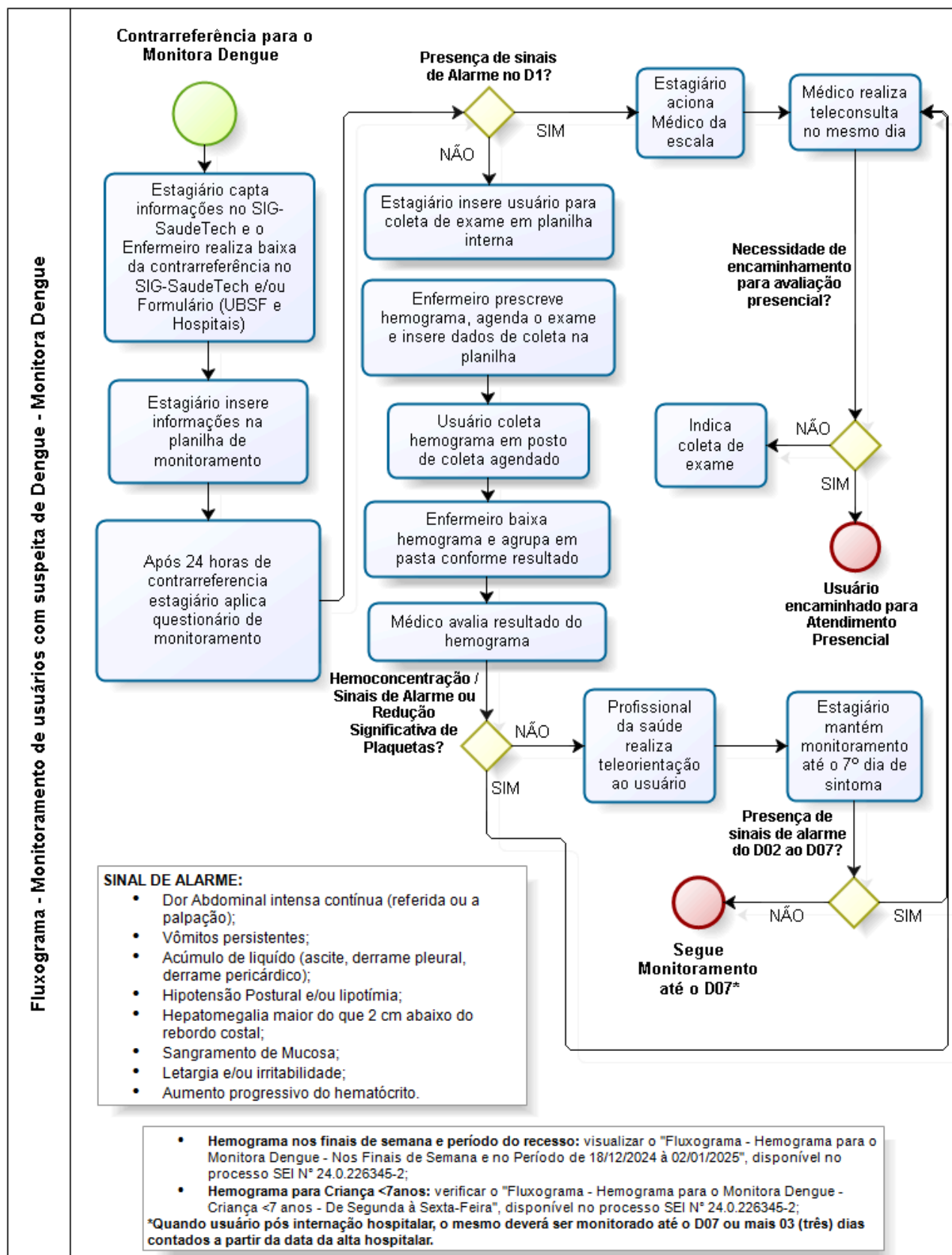
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 6. Fluxograma de Atendimento dos Casos Suspeitos de Dengue nas Unidades de Apoio de Hidratação (UAH)



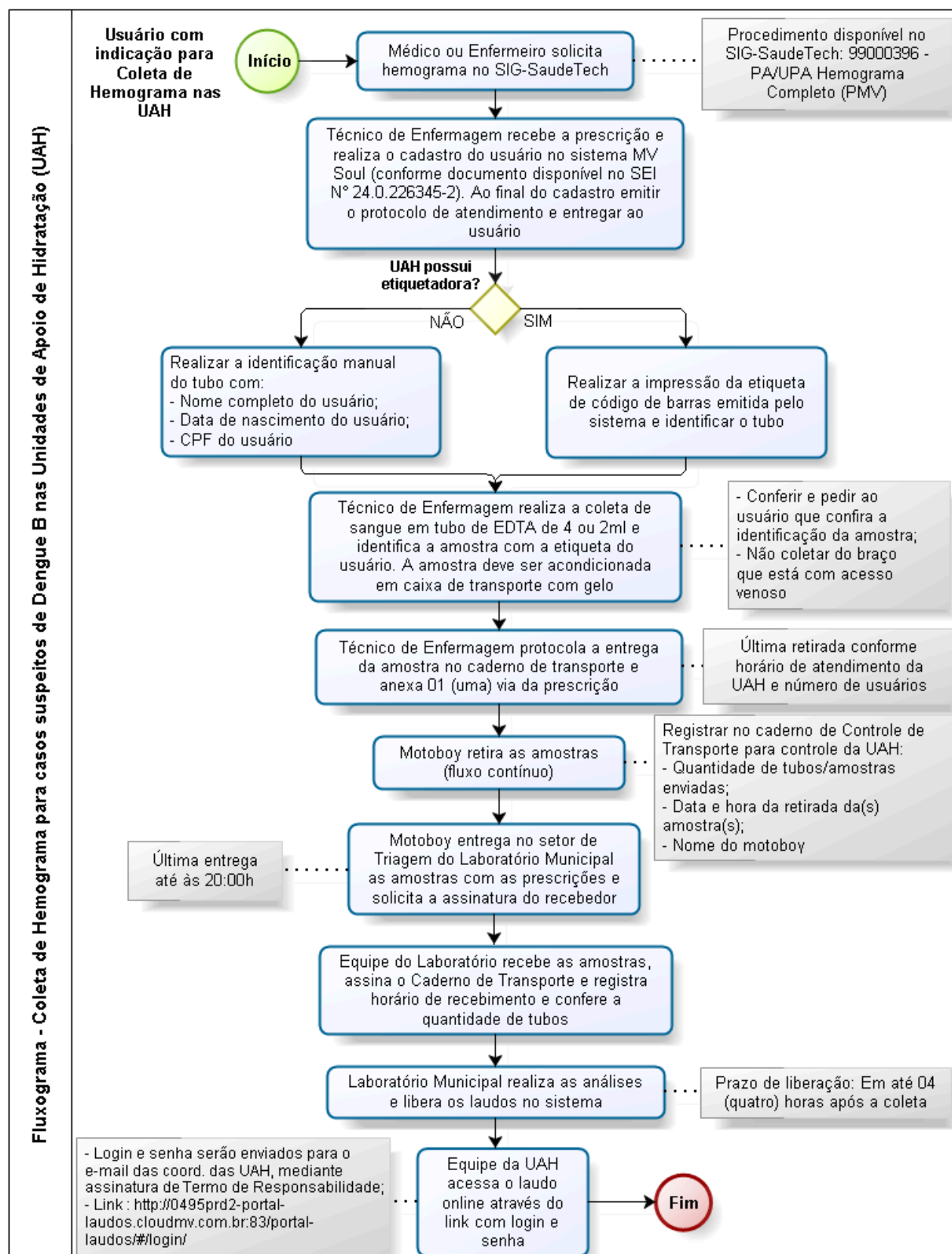
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 7. Fluxograma de Monitoramento dos Casos de Dengue – Monitora Dengue



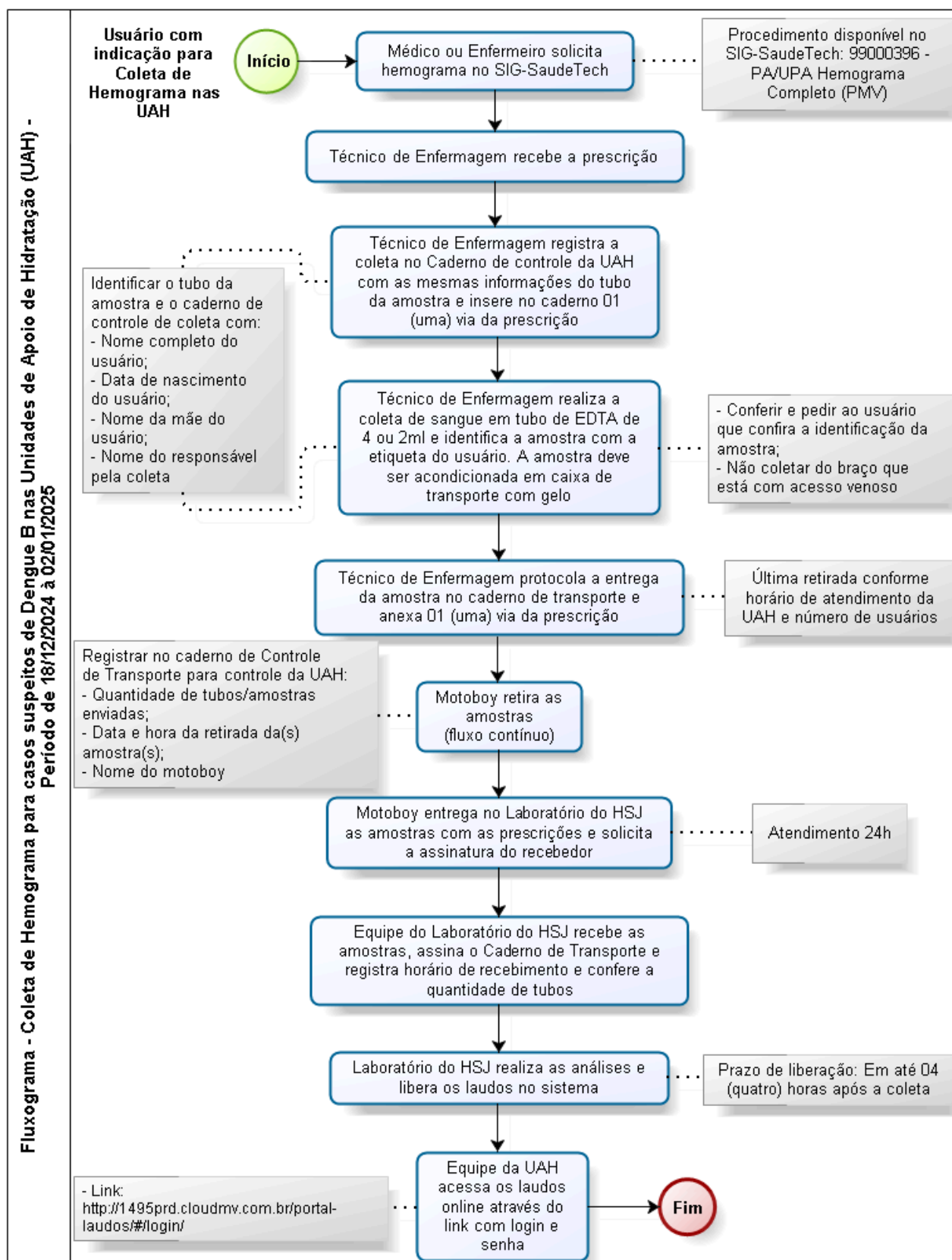
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 8. Fluxograma Coleta de Hemograma para Dengue B nas UAHs



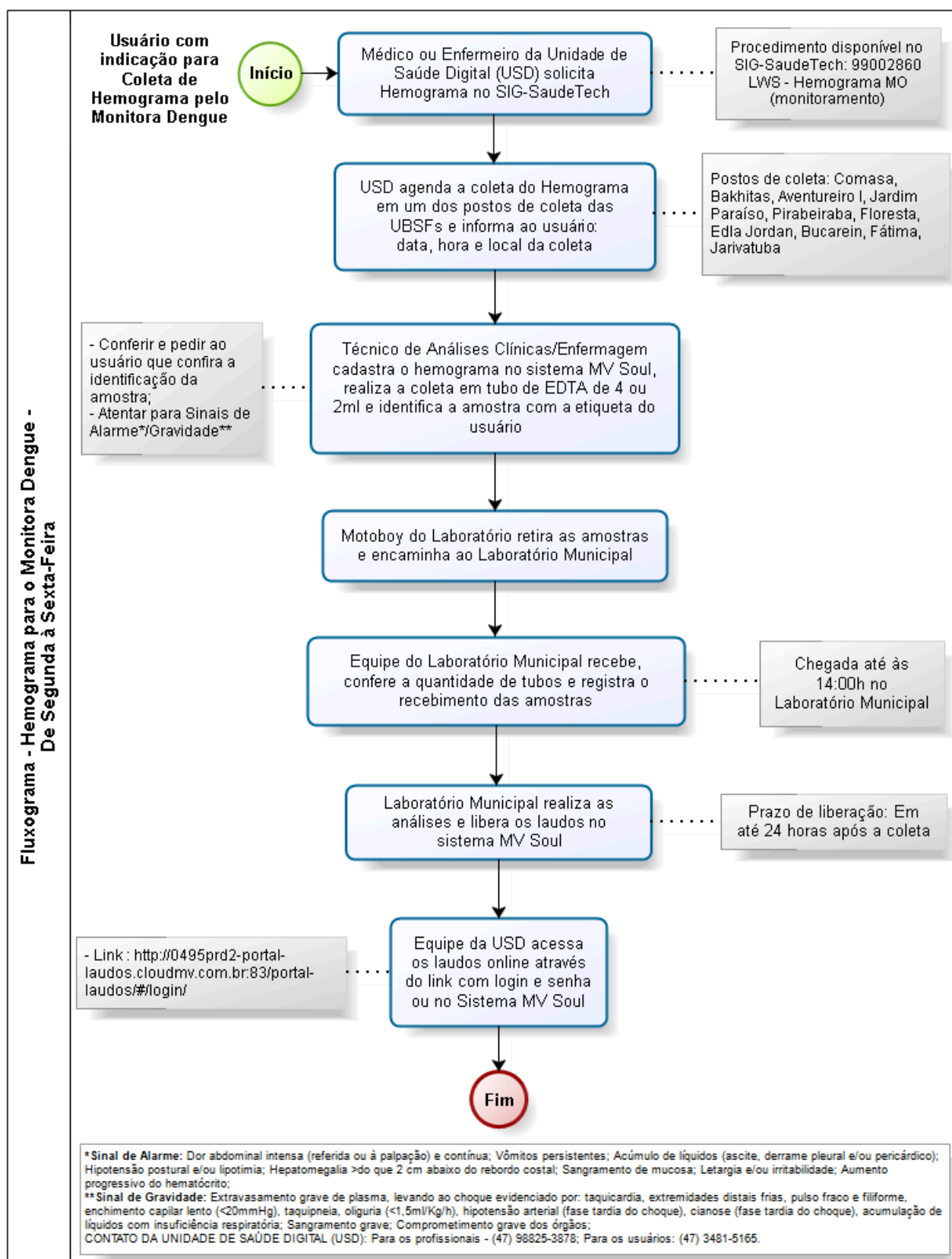
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 9. Fluxograma Coleta de Hemograma para Dengue B nas UAHs no período de 18/12/2024 à 02/01/2025



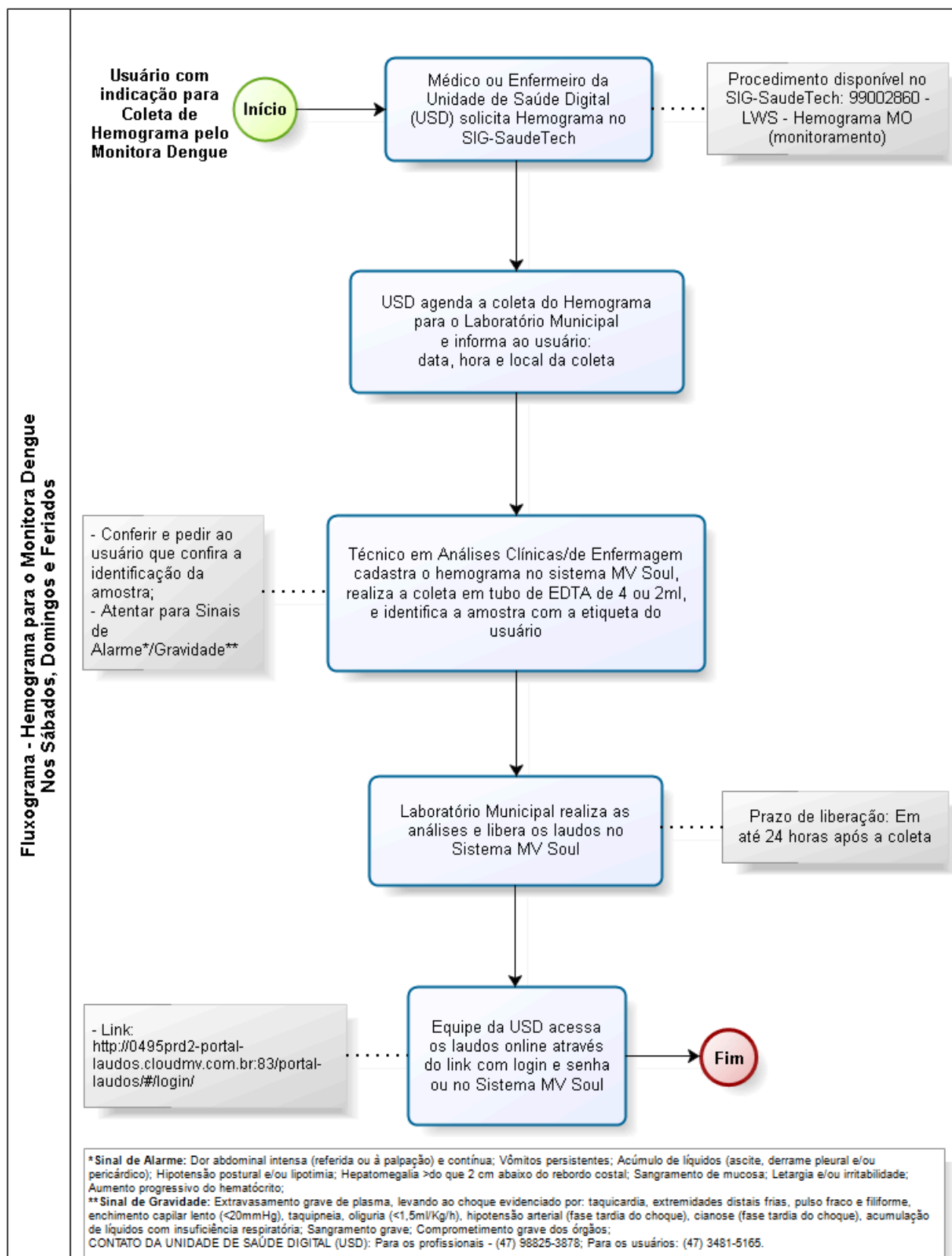
Fonte: NGA, 2024.

Anexo 10. Fluxograma Coleta de Hemograma para o Monitora Dengue - de Segunda à Sexta-Feira



Fonte: NGA, 2024.

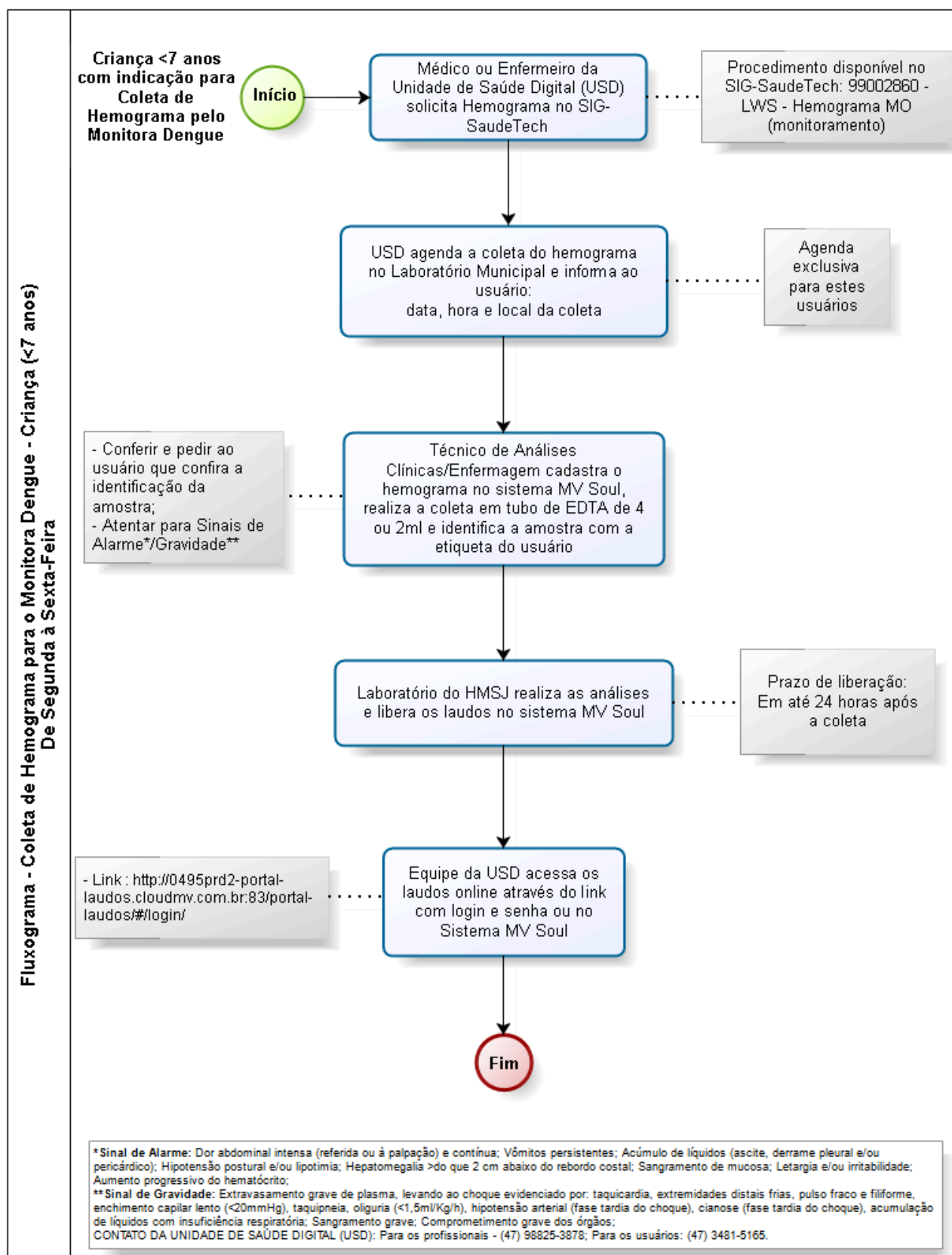
Anexo 11. Fluxograma Coleta de Hemograma para o Monitora Dengue - nos Sábados, Domingos e Feriados



Fonte: NGA, 2024.



Anexo 12. Fluxograma Coleta de Hemograma no Monitora Dengue para < de 7 anos - de Segunda à Sexta-Feira



Fonte: NGA, 2024.